

08 - ANATOMIE FMPM ANATOMIE ANNEXE OVAIRE TROMPE PR. ABOUFALAH

(0:01 - 0:46)

Bonjour, ce cours concerne l'anatomie des annexes de l'utérus, à savoir les ovaires et la trompe. Comme objectif pour ce cours, c'est de savoir situer l'organe et son rôle, sa description, connaître ses rapports, sa vascularisation, et puis connaître les principales implications de l'anatomie en pratique clinique. L'appareil génital féminin occupe la loge génitale de la cavité pelvienne, en arrière de la loge viscérale et en avant de la loge rectale.

(0:47 - 1:34)

La loge génitale est limitée en antérieur par le septum physico-vaginal et en postérieur par le septum recto-génital et latéralement par les lames sagittales. La loge génitale contient l'utérus, les annexes de l'utérus, à savoir les trompes et les ovaires, et une grande partie du vagin. Tous ces éléments, sauf les ovaires, sont recouverts de péritoine, dressant ainsi d'une paroi latérale à l'autre paroi du pelvis, une véritable cloison transversale appelée le ligament large.

(1:36 - 2:19)

Sur cette vue stéoscopique, on voit l'utérus qui occupe la partie médiane de l'excavation pelvienne, en arrière de la vessie, en avant du rectum, et on voit les annexes qui s'étalent de la cornu utérine vers la paroi latérale du pelvis. Et là, c'est la trompe sur toute sa longueur, et on reconnaît l'ovaire par sa couleur caractéristique qui est blanc-rosé. L'anatomie des ovaires L'ovaire est la gonade mère de la femme.

(2:19 - 2:50)

Il s'agit d'une glande exocrine qui produit les follicules, les ovules, et c'est aussi une glande endocrine qui sécrète des hormones stéroïdes. Elle se situe dans la grande cavité péritoniale contre la paroi pelvienne latérale. L'ovaire a une forme d'une amande de couleur blanchâtre, en position à peu près verticale.

(2:51 - 3:37)

On lui décrit deux faces, une face latérale et une face médiale, et deux bords, un bord libre dorsal et le bord mésovarique qui est ventral, et c'est là où siège l'ile de l'ovaire, et aussi c'est la zone de réflexion du péritoine. On distingue aussi deux pôles, un pôle supérieur dit extrémité tubaire et un pôle inférieur dit extrémité utérine. L'ovaire a une consistance ferme, elle est lisse et régulière avant la puberté, et avec le développement des follicules durant la période d'activité génitale, elle devient mûrissante.

(3:37 - 4:09)

Après la ménopause, elle s'atrophie et devient sclérée. Ses dimensions moyennes chez la femme adulte, c'est-à-dire en période d'activité génitale, elle a une longueur de 4 cm pour une largeur de 2 cm et une épaisseur de 1 cm. Le poids moyen est de 8 g. Quels sont les rapports péritoniaux de l'ovaire ? L'ovaire est un organe presque entièrement dépourvu de péritoine.

(4:09 - 4:47)

Le péritoine recouvre juste son bord ventral au niveau de l'huile. Ses moyens de fixité sont le mesovarium, le ligament utéro-ovarien ou dit aussi ligament propre de l'ovaire, le ligament tubo-ovarien et le ligament lombo-ovarien ou ligament suspenseur de l'ovaire qui accompagne les vaisseaux ovariens. Ses rapports avec les organes se font essentiellement avec les ondes grêles et le côlon sigmoïde.

(4:50 - 5:13)

La vascularisation provient de deux sources. L'artère ovarienne qui est une branche directe de l'aorte et une branche de l'artère utérine qui est une branche de l'artère hypogastrique ou l'ilac interne. L'artère ovarique naît de la face ventrale de l'aorte au niveau de L2.

(5:14 - 5:58)

Il suit le ligament lombo-ovarien, croise l'urtère à la hauteur de L3 et se termine au niveau de l'extrémité tubaire de l'ovaire par l'artère ovarique latérale qui s'anastomose avec une branche de l'artère utérine et donne une cour latérale pour vasculariser la trompe. Il s'agit de l'artère tubaire latérale. L'artère utérine naît de la trompe ventrale de l'artère iliac interne, atteint l'ovaire au niveau de son extrémité utérine et donne trois branches.

(5:59 - 6:55)

D'abord l'artère rétrograde du fond utérin qui est destiné à vasculariser le fond utérin et l'artère tubaire médiale qui va s'anastomoser avec l'artère tubaire latérale pour former l'arcade tubaire. Et puis une autre branche, l'artère ovarique médiale qui s'anastomose avec l'artère ovarique latérale. Les veines forment un plexus veineux complexe au niveau de l'ovaire qui devient satellite des artères et rejoint les veines utérines qui rejoignent la veine iliac interne homolatérale et les veines ovariques qui rejoignent du côté droit directement la veine cave et du côté gauche elles vont se jeter dans la veine rénale gauche.

(6:57 - 7:32)

Les lymphatiques, deux collecteurs, les collecteurs de ligaments lombo-ovariens qui vont rejoindre les lymphatiques le groupe latéro-cave, pré-cave et latéro-aortique et les noeuds lymphatiques pelvien-ilac. Et puis l'innervation provient du plexus épigastrique. Concernant l'anatomie de la trompe utérine, la trompe utérine est un canal persymétrique qui conduit l'ovule à

l'utérus.

(7:33 - 7:57)

C'est le site habituel de la rencontre avec le spermatozoïde. Donc c'est l'organe de la fécondation. Le ligament large est une cloison péritoneale à deux feuilles persymétriques tendues de chacun des bords latéraux de l'utérus à la paroi pelvienne latérale en recouvrant les deux trompes.

(8:00 - 8:30)

Concernant la description anatomique des ovaires de la trompe, la trompe mesure 10 à 14 cm de long avec quatre segments. Un segment utérin non visible, puisque situé même dans l'épaisseur de la corne utérine. Un segment ismique qui est horizontal, obliquant dorsal et latéral.

(8:30 - 9:00)

L'ampoule qui longe le bord ventral de l'ovaire, puis se replie en arrière et en bas sur la face médiale. Et puis le pavillon qui est en forme d'un tonneau qui est appliqué sur la face médiale de l'ovaire. Son pourtour présente 10 à 15 franges, dans la plus longue appelée frange ovarique, et adhère à l'ovaire en suivant le ligament tubo-ovaire.

(9:02 - 9:35)

Le pavillon est ouvert dans la grande cavité péritoneale par l'ostéome abdominal, ce qui explique la possibilité d'avoir des grossesses extra-utérines et des infections qui peuvent se propager par voie ascendante. Concernant la configuration externe, la trompe présente quatre configurations internes. La trompe présente quatre tuniques, de l'intérieur vers l'extérieur.

(9:35 - 10:05)

Il y a une muqueuse qui est très plissée, une musculeuse en deux couches, interne circulaire et externe longitudinal, et une unique conjonctive, et puis la séreuse péritoneale. Les rapports péritoneaux se font essentiellement avec le ligament large. Le ligament large contient la trompe et s'arrête au niveau du pavillon, à la limite des franges, et n'inclut pas les ovaires.

(10:06 - 10:31)

Il a une forme d'une cloison transversale quadrilatère. Elle est constituée par le prolongement latéral des deux feuilles péritoneaux, ventrales et dorsales, qui recouvrent l'un la face antérieure, l'autre la face postérieure, de l'utérus. Et on le compare à un drap plié en deux qu'on met asséché sur une corde à linge.

(10:34 - 10:58)

Le ligament large est formé par l'union des deux feuilles péritoneales antérieures et postérieures. Les deux feuilles s'écartent l'une de l'autre, reposant sur le plancher pelvien et se poursuivant par le péritoine pariétal. Un bord médial qui suit le bord latéral de l'utérus, et un bord latéral qui s'insère sur la paroi pelvienne latérale.

(10:59 - 11:36)

Mais cet état de base simple des parts se complique du fait de la présence, de la part de l'autre de la trompe, d'éléments ligamentaires appelés aussi ailerons. Et on distingue au niveau du ligament large deux segments différents. Un segment supérieur dit mesomètre, constitué de trois ailerons, de forme triangulaire à base pariétale et à sommet utérin, et qui converge vers la corne utérine.

(11:37 - 12:00)

En haut, il y a l'aileron médian, tubaire, appelé aussi mesosalpinx, englobe la trompe et ses vaisseaux et correspond au bord cranial du ligament large. En avant, c'est l'aileron ventral, funiculaire, c'est l'aileron du ligament rond. Il est en effet sous-tendu par le ligament rond.

(12:00 - 12:43)

Ce ligament est tendu de la corne utérine jusqu'à la grande lèvre en passant par le canal inguinal. En arrière, on trouve l'aileron dorsal, ou le mesovarium, sous-tendu de médial en latéral par le ligament utéro-ovarien, le bord mesovarique de l'ovaire et une partie du ligament lombo-ovarien. Un segment inférieur qui correspond au bord caudal du ligament large et qui renferme un tissu cellulofibreux et qu'on appelle le paramètre, qui est un élément anatomique très très important.

(12:43 - 13:18)

En effet, le paramètre constitue la partie inférieure du ligament large qui est formée d'un tissu cellulaire dense et se poursuit en caudal par le paravagin. Le rapport essentiel dont le paramètre est celui de l'uretère pelvien est l'artère utérine. L'artère utérine décrit une crosse qui lui fait surcroiser l'uretère à ce niveau-là et il s'agit d'un rapport majeur lors de la bordure chirurgicale de l'utérus.

(13:22 - 13:51)

Là, sur ce schéma-là, la partie supérieure est le mesomètre et la partie inférieure est le paramètre. Au niveau du mesomètre, il y a l'aileron médian tubaire, l'aileron antérieur ventral funiculaire ou du ligament rond et en postérieur, c'est le mesovarium. La vascularisation.

(13:53 - 15:02)

La trompe est vascularisée par une artère infratubaire formée par l'anastomose de l'artère tubaire latérale qui est une branche collatérale de l'ovarique, l'artère tubaire médiale qui est une branche terminale de l'utérine et les veines sont satellites des artères et les lymphatiques rejoignent les lymphatiques l'utérus et de l'ovaire et l'innervation provient du plexus épigastrique. Concernant la vascularisation des annexes, elle provient de l'artère ovarienne et de l'artère utérine. L'artère utérine, au niveau de la corne utérine, va donner un rameau tubaire médial et un rameau ovarien médial et qui vont s'anastomoser avec le remoulant qui vient de l'artère ovarique qui donne un rameau ovarique latéral et un rameau tubaire latéral.

(15:10 - 15:45)

Quels sont les intérêts pratiques de l'anatomie ? C'est très nombreux pour l'exploration des annexes en cas de bilan d'infertilité, de stérilité ou en cas de suspicion de tumeur de l'ovaire. La celluloscopie, l'exploration endoscopique avec le test bleu de Mytilène, on injecte du bleu qui va à travers le col, qui va passer dans la cavité utérine, passer à travers les trompes et sortir dans la cavité péritonéale. On dit que le test est positif, c'est-à-dire que les trompes sont perméables quand on voit du bleu dans la cavité abdominale.

(15:46 - 16:18)

L'échographie par voie suspubienne ou vaginale permet d'explorer les ovaires essentiellement en cas de tumeur. L'hystérosalpingographie, on injecte un produit radiopaque par le col qui va passer au niveau de l'endocole, au niveau de la cavité utérine et va passer à travers les trompes pour sortir dans la cavité péritonéale. Donc le passage du produit de contraste à travers les trompes dans la fosse ovarique.

(16:19 - 16:39)

Le scanner, la tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique sont demandées en cas de tumeur de l'ovaire, puis dans la chirurgie sur les annexes. On peut faire une annexectomie, c'est-à-dire l'ablation de la trompe avec l'ovaire. Une salpingectomie, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'ablation juste de la trompe.

(16:40 - 17:01)

Quistectomie, lorsqu'il y a un kyste au niveau de l'ovaire, on enlève juste le kyste. Souvent il y a des adhérences entre les différents organes, surtout dans le cadre de l'infertilité, on l'appelle adhésiolyse. Et puis des fois on fait des ligatures, sections de trompe chez les femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants.

Je vous remercie.